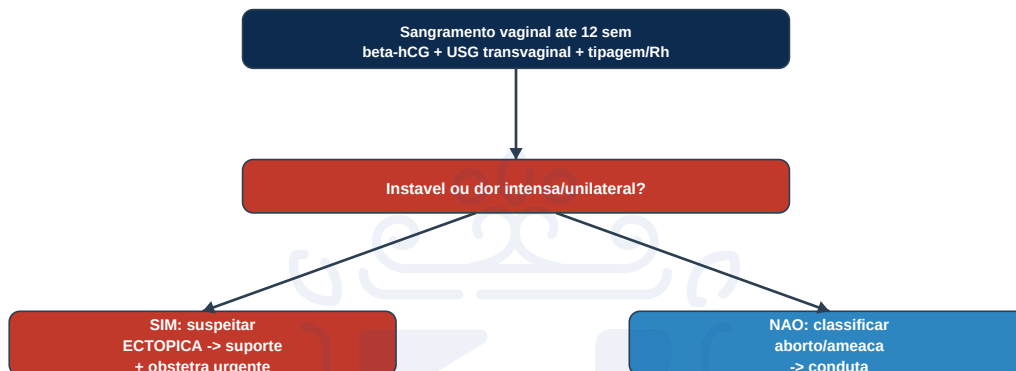


SANGRAMENTO NO 1º TRIMESTRE

FLUXOGRAMA — EXCLUIR ECTÓPICA

1o TRIMESTRE — beta-hCG + USG TRANSVAGINAL



DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É

- Sangramento vaginal até a 12ª semana, com ou sem dor abdominal
- Etiologias variam de benignas a potencialmente fatais (gravidez ectópica)
- Gestacionais: ameaça de aborto, aborto (em evolução/incompleto/completo), ectópica, gestação anembrionária, doença trofoblástica
- Não gestacionais: infecção vaginal/cervical, trauma, pólipos, sangramento de implantação

RED FLAGS

SUSPEITAR DE ECTÓPICA / GRAVIDADE

- Dor abdominal intensa ou UNILATERAL
- Sangramento vaginal volumoso
- Sinais de instabilidade hemodinâmica
- Síncope ou lipotímia
- História prévia de gravidez ectópica
- Ectópica rota é emergência — suporte + obstetra/cirurgia imediatos

AValiação E EXAMES

ESSENCIAIS

- Anamnese: idade gestacional (DUM/US), início/quantidade/aspecto, coágulos/restos, dor, antecedente obstétrico, tipagem
- Exame: estado geral, sinais vitais, abdome; especular (sangramento, colo aberto/fechado); sinais de choque
- Beta-hCG QUANTITATIVO + USG TRANSVAGINAL (chave para topografar a gestação)
- Tipagem sanguínea e fator Rh; Hb/Ht se sangramento importante
- Variáveis: coagulograma, beta-hCG seriado, USG abdominal, exames infecciosos se suspeita

DIAGNÓSTICO — COLO E USG

Quadro	Colo / achado	Conduta
Ameaça de aborto	Colo FECHADO, embrião/BCF presente	Conduta expectante; orientações de alarme
Aborto em evolução/inevitável	Colo ABERTO, sangramento	Avaliação obstétrica (esvaziamento)
Aborto incompleto	Colo aberto, restos à USG	Esvaziamento (AMIU/curetagem) ou misoprostol
Gravidez ectópica	hCG sem saco gestacional intrauterino compatível; massa anexial	Encaminhamento IMEDIATO (metotrexato x cirurgia)

TRATAMENTO NO PS

Rx POR CENÁRIO

Ameaça de aborto: conduta expectante + repouso relativo + orientações
Aborto incompleto/em evolução: avaliação obstétrica para esvaziamento
Gravidez ectópica: encaminhamento imediato (suporte se instável)
Instabilidade: 2 acessos, SF 0,9% EV, suporte e transferência URGENTE
IMUNOGLOBULINA ANTI-D para gestante Rh NEGATIVO (conforme indicação)
Analgesia com dipirona/paracetamol; EVITAR AINES

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: sangramento volumoso/persistente, dor importante, suspeita/confirmação de ectópica, instabilidade, queda de Hb, necessidade de procedimento
- ☐ ALTA: sangramento leve/cessado, estável, sem sinais de gravidade, USG sem alto risco, retorno garantido
- ☐ Casa: analgésico se necessário, repouso relativo, evitar relações (se indicado), seguimento obstétrico
- ☐ Não esquecer a imunoglobulina anti-D na Rh negativo
- ☐ Retorno IMEDIATO: aumento do sangramento, dor intensa, tontura/desmaio, febre

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante ____ semanas com sangramento de 1o trimestre; dor ____; estabilidade ____.
- Beta-hCG ____; USG transvaginal: ____ (tópica/ectópica/restos); tipagem Rh ____.
- Condutas: analgesia, acesso/SF, anti-D se Rh negativo; suspeita de ectópica: ____.
- Solicito serviço com obstetrícia (ectópica/instabilidade = urgente).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante de 7 semanas com dor pélvica unilateral intensa, sangramento e lipotimia; beta-hCG positivo sem saco gestacional intrauterino à USG. Hipótese e conduta?

- A) Ameaça de aborto — repouso e alta
- B) Gravidez ectópica — suporte hemodinâmico e encaminhamento obstétrico/cirúrgico imediato
- C) Aborto completo — alta
- D) Infecção urinária — antibiótico oral
- E) Pólipo cervical — observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os dois exames essenciais na avaliação do sangramento de 1o trimestre?

- A) Hemograma e PCR
- B) Beta-hCG quantitativo e ultrassonografia transvaginal
- C) TSH e glicemia
- D) Coagulograma e D-dímero
- E) Radiografia de abdome e urina 1

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Gestante de 8 semanas, sangramento leve, colo FECHADO, embrião com BCF à USG. Diagnóstico e conduta?

- A) Aborto incompleto — curetagem
- B) Ameaça de aborto — conduta expectante e orientações
- C) Gravidez ectópica — metotrexato
- D) Aborto retido — esvaziamento
- E) Doença trofoblástica — quimioterapia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual medida não deve ser esquecida em gestante Rh NEGATIVO com sangramento no 1o trimestre?

- A) Transfusão de plaquetas
- B) Imunoglobulina anti-D (conforme indicação)
- C) Antibiótico profilático
- D) Corticoide
- E) Sulfato de magnésio

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual classe de analgésico deve ser EVITADA no sangramento de 1o trimestre?

- A) Dipirona
- B) AINEs
- C) Paracetamol
- D) Escopolamina
- E) Nenhum precisa ser evitado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor unilateral intensa + lipotímia + beta-hCG positivo SEM saco gestacional intrauterino compatível = gravidez ectópica (possivelmente rota). É emergência: suporte hemodinâmico e encaminhamento obstétrico/cirúrgico imediato.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os exames essenciais são o beta-hCG quantitativo e a USG transvaginal, que juntos topografam a gestação (tópica x ectópica) e avaliam viabilidade/restos, definindo a conduta.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sangramento leve com colo fechado e embrião com BCF presente caracteriza ameaça de aborto: conduta expectante, repouso relativo e orientações de alarme, com seguimento pré-natal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Em gestante Rh negativo com sangramento, deve-se administrar imunoglobulina anti-D (conforme indicação) para prevenir a aloimunização Rh.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Os AINEs devem ser evitados; prefere-se dipirona ou paracetamol para analgesia no sangramento de 1o trimestre.

SM24
Suporte ao Plantão Médico